RELATÓRIO TÉCNICO

Análise dos critérios de caracterização de estágio inicial na coorte PRIME

Documento para discussão com a equipe clínica. Casuística: 133 pacientes com doença de Parkinson, com avaliação registrada até 22/10/2026.

O número de pacientes considerados em estágio inicial muda conforme a regra escolhida. Nesta casuística, 22,6% têm menos de 5 anos desde o início dos sintomas, 75,2% estão com Hoehn & Yahr (H&Y) abaixo de 3 e 43,6% têm exame motor leve no MDS-UPDRS parte III. Tempo de doença, estágio clínico e gravidade do exame são informações complementares. Uma não substitui a outra.

1. Objetivo e escopo

Objetivo. Verificar como diferentes formas de definir estágio inicial alteram o tamanho do grupo e descrever a relação entre o tempo de doença, o estágio de Hoehn & Yahr e a gravidade motora do MDS-UPDRS parte III.

Escopo. A análise inclui os 133 pacientes com doença de Parkinson que têm avaliação clínica com data de coleta até 22/10/2026. Para quem tem mais de uma avaliação, vale a mais recente. Controles saudáveis, os identificadores de teste P000 e P00 e o paciente P048 não entram. O P048 fica de fora porque a duração estimada é de 39 anos e o H&Y é 0, com exame leve e sem medicação antiparkinsoniana. Esse conjunto não se lê como doença típica e distorcia o grupo de estágio baixo. Outros registros com duração muito longa ou igual a zero permanecem na contagem e estão listados para revisão médica.

2. Variáveis utilizadas

As três medidas abaixo descrevem aspectos diferentes da doença. O tempo informa há quanto tempo os sintomas começaram. O H&Y informa o estágio funcional, com atenção para o acometimento dos dois lados do corpo, o equilíbrio e a independência. O MDS-UPDRS parte III informa a gravidade dos sinais motores no dia do exame.

Dimensão	Variável	Como ler
Tempo de doença	Duração desde o início dos sintomas	Idade atual menos a idade de início dos sintomas, em anos.
Estágio clínico	Hoehn & Yahr (H&Y)	Estágio de 0 a 5. Até 2, ainda não há alteração do equilíbrio. Abaixo de 3, inclui o 2,5 e a independência se mantém.
Exame motor	MDS-UPDRS parte III	Leve: até 32 pontos. Moderado: 33 a 58. Grave: 59 ou mais.

A faixa do MDS-UPDRS parte III segue Martínez-Martín e colaboradores (2015). A idade usada na conta é o ano de 2026 menos o ano de nascimento. Quando falta a data de nascimento ou a idade de início, a duração fica em branco e a pessoa não entra nas regras que dependem do tempo.

3. Caracterização da coorte

Indicador	Resultado
Pacientes com Parkinson	**133**
Idade média	61,9 anos
Sexo	87 homens (65,4%); 46 mulheres (34,6%)
Duração mediana	7 anos
H&Y mediano	2,5
MDS-UPDRS parte III	média 39,0; mediana 37

Duração ausente: 0. H&Y ausente: 0. UPDRS III ausente: 0.

Quantidade de pacientes em cada estágio de Hoehn & Yahr.

H&Y	N	% da coorte
1	**12**	9,0%
1,5	**6**	4,5%
2	**43**	32,3%
2,5	**39**	29,3%
3	**23**	17,3%
4	**10**	7,5%

Alguns registros pedem conferência antes de serem lidos como doença típica. Eles continuam incluídos nos números deste relatório.

Paciente	Idade	Duração	H&Y	UPDRS III	Motivo da revisão
P126	70	40	4	44	duração de 30 anos ou mais
P139	70	30	2	40	duração de 30 anos ou mais
P148	49	0	1,5	24	duração igual a zero

4. Impacto da definição de estágio inicial

A mesma casuística produz grupos de tamanhos bem diferentes conforme a regra. A tabela abaixo mostra quantas pessoas cada definição alcança.

Critério	N	% da coorte
H&Y igual ou inferior a 2	**61**	45,9%
H&Y inferior a 3	**100**	75,2%
H&Y igual ou inferior a 3	**123**	92,5%
Duração inferior a 5 anos	**30**	22,6%
H&Y inferior a 3 e duração inferior a 5 anos	**26**	19,5%
H&Y igual ou inferior a 3 e duração inferior a 5 anos	**30**	22,6%
UPDRS III leve (até 32)	**58**	43,6%
H&Y igual ou inferior a 2 e UPDRS III leve	**37**	27,8%
H&Y inferior a 3 e UPDRS III leve	**52**	39,1%

Análise. A regra que exige H&Y igual ou inferior a 3 e duração inferior a 5 anos reúne as mesmas 30 pessoas da regra que olha só a duração. Ninguém com menos de 5 anos de sintomas está acima do estágio 3. Nesta casuística, o que reduz o grupo é o limite de tempo. Dizer que há poucos pacientes iniciais por essa regra equivale a dizer que há poucos pacientes com menos de cinco anos de sintomas.

Corte em H&Y 2. H&Y igual ou inferior a 2 reúne 61 pessoas (45,9%). As outras 39 pessoas do grupo abaixo de 3 estão no estágio 2,5, já com o primeiro sinal de alteração do equilíbrio. Dessas 39, 15 têm exame leve, 16 moderado e 8 grave. Exigir H&Y até 2 e exame leve reúne 37 pessoas (27,8%).

5. Relação entre estágio clínico e gravidade motora

O exame motor se divide de forma equilibrada entre leve e moderado, com menos casos graves: 58 leves (43,6%), 54 moderados (40,6%) e 21 graves (15,8%).

H&Y	UPDRS leve	Moderado	Grave	Total
Igual ou inferior a 2	37	20	4	**61**
Igual a 2,5	15	16	8	**39**
Igual a 3	6	12	5	**23**
Superior a 3	0	6	4	**10**

Análise. Estágio e exame motor caminham juntos de forma moderada (correlação de Spearman 0,48). Ainda assim, não classificam as mesmas pessoas. Entre 100 pacientes com H&Y abaixo de 3, 52 têm exame leve e 48 já têm exame moderado ou grave. No corte até 2 são 61 pessoas, 37 com exame leve. No estágio 2,5 são 39: 15 leves, 16 moderados e 8 graves. O tempo de doença acompanha pouco o estágio (Spearman 0,33, associação fraca) e pouco a gravidade do exame (Spearman 0,22, associação fraca).

6. Pacientes com H&Y inferior a 3 e UPDRS III leve

Este grupo reúne quem está, ao mesmo tempo, em estágio funcional mais baixo e com exame motor leve: 52 pacientes (39,1%). É a situação em que as duas medidas clínicas concordam sobre um quadro mais brando. O tempo de doença não entra nessa definição.

Distribuição por estágio, tempo de doença e uso de medicação antiparkinsoniana, dentro deste grupo.

H&Y	N	% do grupo
1	**12**	23,1%
1,5	**5**	9,6%
2	**20**	38,5%
2,5	**15**	28,8%

Medicação	N	% do grupo
Em uso	**50**	96,2%
Sem uso	**2**	3,8%

Tempo de doença	N	% do grupo
Menos de 5 anos	**19**	36,5%
5 a 10 anos	**27**	51,9%
Mais de 10 anos	**6**	11,5%

Análise. Dos 52 pacientes deste grupo, 19 também têm menos de 5 anos de sintomas. Os outros 33 têm 5 anos ou mais e ficariam de fora se o estágio inicial fosse definido só pelo tempo. 2 não usam medicação antiparkinsoniana. Para a discussão clínica, este grupo descreve doença ainda branda no estágio e no exame, independentemente de há quanto tempo os sintomas começaram. Se o estágio exigir H&Y igual ou inferior a 2, saem as 15 pessoas que estão no 2,5 com exame leve, e o grupo passa a 37 pacientes (27,8%).

Pacientes deste grupo que não usam medicação antiparkinsoniana.

Paciente	Duração (anos)	H&Y	UPDRS III	Observação
P118	5	2	4	Exemplo de doença branda após 5 anos
P091	6	2	11	Exemplo de doença branda após 5 anos

7. Limitação do corte de cinco anos

O tempo de doença se relaciona pouco com a gravidade vista no exame. Há pacientes com muitos anos de sintomas que seguem com H&Y baixo e exame leve, e pacientes com poucos anos que já apresentam comprometimento motor maior.

Duração	UPDRS leve	Moderado	Grave	Total
Menos de 5 anos	20	6	4	**30**
5 a 10 anos	30	22	12	**64**
Mais de 10 anos	8	26	5	**39**

Dois pacientes ilustram o limite de uma regra rígida de menos de 5 anos. Os dois estão em H&Y 2, com exame motor leve, e não usam medicação antiparkinsoniana. Pela avaliação clínica, seguem como doença precoce. Uma regra só de tempo os deixaria de fora.

Paciente	Duração	H&Y	UPDRS III	Medicação
P091	6 anos	2	11	Não
P118	5 anos	2	4	Não

No outro sentido, 10 pacientes com menos de 5 anos já têm exame moderado ou grave (6 moderados e 4 graves). Outro paciente com menos de 5 anos já está em H&Y 3 ou mais, com exame ainda leve. Poucos anos de doença também não garantem um quadro leve.

8. Critérios combinados para discussão

Exigir que todas as condições sejam verdadeiras ao mesmo tempo pode deixar o grupo pequeno demais, porque o limite de 5 anos passa a definir o tamanho. Três combinações ajudam a equipe a discutir um meio-termo. A terceira não usa o tempo de doença. Elas não são definições consagradas na literatura. São propostas para organizar esta casuística.

Critério 1. H&Y inferior a 3 e, além disso, duração inferior a 5 anos ou UPDRS III até 32. Resultado: 59 pacientes (44,4%). O estágio baixo é obrigatório. A pessoa também precisa ter pouco tempo de doença ou exame motor leve.

Critério 2. Duração inferior a 5 anos ou, ao mesmo tempo, H&Y inferior a 3 e UPDRS III até 32. Resultado: 63 pacientes (47,4%). Há duas formas de entrar: pouco tempo de sintomas ou, mesmo com mais tempo, estágio baixo e exame leve. P091 e P118 entram pela segunda forma.

Critério 3. H&Y inferior a 3 e UPDRS III até 32, sem usar o tempo de doença. Resultado: 52 pacientes (39,1%). Entram apenas as pessoas com estágio baixo e exame leve, tenha a doença começado há poucos anos ou há muitos.

Corte até 2. A mesma leitura do critério 3, com H&Y igual ou inferior a 2 no lugar de inferior a 3, reúne 37 pacientes (27,8%). Ficam de fora as 15 pessoas no estágio 2,5 que ainda têm exame leve. Olhando só o estágio, até 2 alcança 61 pessoas (45,9%), e abaixo de 3 alcança 100 (75,2%).

Estratégia	N	% da coorte
Só o tempo: duração inferior a 5 anos	**30**	22,6%
Só o estágio: H&Y inferior a 3	**100**	75,2%
Só o estágio, corte até 2	**61**	45,9%
Só o exame: UPDRS III até 32	**58**	43,6%
Critério 1: estágio baixo e (pouco tempo ou exame leve)	**59**	44,4%
Critério 2: pouco tempo ou (estágio baixo e exame leve)	**63**	47,4%
Critério 3: H&Y inferior a 3 e UPDRS III até 32, sem o tempo	**52**	39,1%
H&Y igual ou inferior a 2 e UPDRS III até 32, sem o tempo	**37**	27,8%

Síntese. Em 133 pacientes, o tempo, o H&Y e o UPDRS III respondem a perguntas diferentes. Menos de 5 anos de sintomas alcança 30 pessoas (22,6%). H&Y abaixo de 3 alcança 100 (75,2%). H&Y até 2 alcança 61 (45,9%). Exame motor leve alcança 58 (43,6%). O critério 3, só com H&Y abaixo de 3 e exame leve, sem usar o tempo, reúne 52 pessoas (39,1%). O mesmo par de condições com H&Y até 2 reúne 37 (27,8%).

Referência da classificação do MDS-UPDRS parte III: Martínez-Martín P, Rodríguez-Blázquez C, Alvarez M, et al. Parkinson's disease severity levels and MDS-Unified Parkinson's Disease Rating Scale. Parkinsonism & Related Disorders. 2015;21(1):50-54.